

Cơ chế trụ Ngủ nghỉ

Bản nháp v0.1, ngày 04/10/2026. Tài liệu triển khai trụ thứ năm trong *Lý luận Lục Dưỡng v0.3*, cùng khung với các trụ trước. Ký hiệu: ☯ = Lục Dưỡng vận dụng; **[C1]** **[C2]** **[C3]** = cấp bằng chứng (mục IX của lý luận).

Cần thẩm định: trích dẫn kinh điển cần lương y đối chiếu nguyên văn. Khuyến nghị và cờ đỏ cần **bác sĩ chuyên về giấc ngủ** (thần kinh, hô hấp, tâm thần) và chuyên gia tâm lý duyệt. Các nghiên cứu nêu tên chỉ để định hướng, cần kiểm tra lại trước khi trích dẫn công khai.

Cách đọc tài liệu

Mỗi cơ chế là **chuỗi nhân quả từ một việc làm đến một trạng thái**, gồm bốn phần: **Đông lý, Tây chứng, tầng được nuôi, trong app**.

Trụ Ngủ nghỉ có **một cơ chế nền và sáu cơ chế**, chia ba nhóm:

Nhóm	Câu hỏi	Cơ chế
A. Giấc ngủ	Ngủ bao nhiêu, lúc nào	1. Túc miên: ngủ đủ · 2. Thuận thời: giờ đều, ánh sáng đúng lúc, giấc trưa
B. Điều kiện để ngủ	Vì sao ngủ không ngon	3. Tâm yên thì ngủ · 4. Vị hoà thì ngủ · 5. Chỗ ngủ yên
C. Nghỉ	Nghỉ ngơi ban ngày	6. Bất vọng tác lao: nghỉ giữa giờ, ngày nghỉ, hồi phục

Nền chung là **cơ chế gốc: âm dương giao thì ngủ**.

Hành chủ đạo: Thuỷ (Thận tàng; giấc ngủ là "mùa đông của một ngày"). **Tạng cùng tham gia:** tạng Tâm (thần yên thì ngủ), Can ("*nhân ngọa huyết quy ư Can*"), Tỳ Vị. Việc gán hành là ☯.

Cơ chế gốc: âm dương giao thì ngủ

Đông lý

- Linh Khu*, "*Khẩu vấn*" giải thích ngủ và thức bằng sự vận hành của dương khí và âm khí: **dương khí hết, âm khí thịnh thì mắt nhắm (ngủ); âm khí hết, dương khí thịnh thì tỉnh dậy**. (*Cần đối chiếu nguyên văn*.)
- Linh Khu* (các thiên "Doanh vệ sinh hội", "Đại hoặc luận") mô tả **vệ khí ban ngày đi ở phần dương, ban đêm vào phần âm**; vệ khí vào âm thì ngủ, ra dương thì thức. (*Cần đối chiếu*.)

- *Tổ VẤN, "Ngủ tạng sinh thành": "Nhân ngọa huyết quy ư Can":* người nằm thì huyết về Can. Ngủ là lúc huyết được tàng, được dưỡng.
- *Tứ khí điều thần đại luận:* mùa đông "**tảo ngọa văn khởi**", ngủ là **tàng**: thu giữ, bồi đắp tinh.

Chuỗi Đông lý: ngày dương động, đêm âm tĩnh → tối đến dương khí vào âm → thần về tàng ở tạng Tâm, huyết về Can, tinh được Thận tàng → sáng dậy dương khí ra ngoài, tinh thần sáng khoái. Thức khuya là **hao âm, hao tinh**: đúng khái niệm "hao tổn" trong tạng Thân của lý luận (mục II).

Tây chứng

Hiện tượng hiện đại	Tương ứng cổ truyền	Cấp
Mô hình hai quá trình (Borbély): áp lực ngủ tăng dần khi thức, cộng với đồng hồ sinh học ngày đêm, quyết định lúc buồn ngủ và lúc tỉnh	Dương khí hết thì ngủ; ngày đêm âm dương	C1
Khi ngủ, cơ thể tiết hormone tăng trưởng, củng cố trí nhớ, điều hoà miễn dịch, chuyển hoá; não tăng làm sạch chất thải (hệ glymphatic, chủ yếu từ nghiên cứu động vật)	Ngủ là tàng, là dưỡng	C1 (trí nhớ, hormone, miễn dịch) / C2 (glymphatic ở người)
Thiếu ngủ kéo dài liên quan béo phì, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, trầm cảm, tai nạn	Hao âm, hao tinh	C1
Thiếu ngủ làm phản ứng cảm xúc mạnh hơn, khó điều tiết	Thần không được tàng	C1

Hệ quả cho app 🍷

Mọi lời khuyên trả lời một câu: **việc này giúp dương vào âm (dễ ngủ, ngủ sâu) hay giữ dương ở ngoài (khó ngủ, ngủ chập chòn)?** Tín hiệu tự cảm nhận: **dễ vào giấc, ít thức giấc giữa đêm, sáng dậy thấy đã được nghỉ, ban ngày không buồn ngủ rũ.**

A. Giấc ngủ

Cơ chế 1. Túc miên: ngủ đủ

Đông lý.

- "**Khởi cư hữu thường**" (*Thượng cổ thiên chân luận*): sinh hoạt có nề nếp.
- Ngủ đủ thì tinh khí được bồi; thiếu ngủ thì "hao" (Thủy kém thì Mộc không được nuôi: không có sức tập, theo vòng tương sinh của lý luận mục IV).
- Nhưng "**cửu ngọa thương khí**" (*Tuyên minh ngũ khí*): nằm quá lâu cũng hại khí.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Người trưởng thành (18–60 tuổi) nên ngủ ít nhất 7 giờ/đêm (khuyến nghị đồng thuận AASM và SRS, 2015); khoảng thường dùng 7–9 giờ	C1
Người cao tuổi cần khoảng 7–8 giờ; giấc ngủ nông hơn, dễ thức giấc hơn là thay đổi bình thường theo tuổi	C1
Nhu cầu ngủ khác nhau giữa các người; người ngủ ngắn bẩm sinh thật sự rất hiếm	C1–C2
Ngủ dài thường xuyên (trên khoảng 9–10 giờ) đi kèm nguy cơ sức khoẻ, nhưng thường là đấu hiệu của bệnh (trầm cảm, suy giáp, ngưng thở khi ngủ...) chứ không phải nguyên nhân	C2
"Ngủ bù" cuối tuần chỉ bù được một phần; lệch giờ ngủ giữa ngày thường và cuối tuần ("lệch múi giờ xã hội") liên quan chuyển hoá kém hơn	C2

Tăng được nuôi: Thân ●●●, Thần ●●●, Khí ●, Tâm ●.

Trong app:

- Thước đo chính: **thời gian ngủ ước tính** (giờ đi ngủ đến giờ dậy, trừ thời gian thức), từ check-in hoặc thiết bị.
- Mục tiêu theo tuổi: người trưởng thành **ít nhất 7 giờ**; không ép đạt con số tuyệt đối nếu người dùng thấy tỉnh táo.
- Lời khuyên với người ngủ ít: **lùi giờ đi ngủ sớm 15 phút mỗi tuần** 🕒, không đột ngột lên giường sớm hơn 1–2 tiếng (để nằm thao thức).
- Với người ngủ nhiều kéo dài kèm mệt: **không khuyên "ngủ ít lại"**, mà chạy cờ đỏ, khuyên đi khám (lý luận mục X).

Cơ chế 2. Thuận thời: giờ đều, ánh sáng đúng lúc, giấc trưa

Đông lý.

- *Tứ khí điều thần đại luận* điều chỉnh giờ ngủ theo mùa: xuân hạ "**dạ ngọa tảo khởi**" (ngủ muộn, dậy sớm), thu "**tảo ngọa tảo khởi**", đông "**tảo ngọa văn khởi, tất đãi nhật quang**" (ngủ sớm, dậy muộn, đợi có nắng).
- Dưỡng sinh cổ truyền coi trọng "**Tý Ngọ giác**": ngủ vào giờ Tý (23h–1h) và chợp mắt giờ Ngọ (11h–13h), hai thời điểm âm dương giao nhau [C3].
- Giờ Sửu (1h–3h) là giờ kinh Can vượng, lúc huyết về Can; thức qua giờ này là hao huyết [C3].

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Ánh sáng là tín hiệu mạnh nhất chỉnh đồng hồ sinh học: ánh sáng buổi sáng giúp ngủ sớm hơn vào tối; ánh sáng mạnh buổi tối (kể cả màn hình) làm chậm tiết melatonin, lùi giờ buồn ngủ	C1
Giờ đi ngủ và thức dậy đều đặn (kể cả cuối tuần) liên quan giấc ngủ tốt hơn và sức khoẻ chuyển hoá tốt hơn	C1–C2
Giờ thức dậy cố định là thành phần cốt lõi của điều trị mất ngủ (CBT-I)	C1

Hiện tượng	Cấp
Giấc ngủ trưa ngắn (khoảng 10–30 phút) đầu giờ chiều tăng tỉnh táo; ngủ trưa dài, ngủ muộn buổi chiều có thể làm khó ngủ ban đêm	C1–C2
Ngủ trưa dài thường xuyên (trên khoảng 1 giờ) đi kèm một số nguy cơ sức khoẻ ở người lớn tuổi, nhưng có thể là dấu hiệu chứ không phải nguyên nhân	C2
Mỗi người có thiên hướng ngủ sớm hay muộn (kiểu thời sinh học) khác nhau, có phần do di truyền	C1
Giờ Tý, giờ Sửu có ý nghĩa đặc biệt	C3

Văn hoá Việt ☞: ngủ trưa là thói quen phổ biến, nhất là ở công sở, trường học. Đây là **điểm mạnh nên giữ**, chỉ cần điều chỉnh độ dài (Tý Ngọ giấc C3 gặp giấc trưa ngắn C1–C2).

Tăng được nuôi: Thân ●●, Thần ●●, Khí ●.

Trong app:

- **Neo giờ dậy** ☞: người dùng chọn một giờ thức dậy giữ đều cả tuần (chênh không quá khoảng 1 giờ vào cuối tuần).
- **"Đón nắng sáng"** ☞: 10–30 phút ngoài trời trong 1–2 giờ đầu sau khi dậy (nối trụ Môi trường, trụ Luyện tập: đi bộ buổi sáng).
- **"Hoàng hôn trong nhà"** ☞: 1–2 giờ trước ngủ giảm đèn sáng, chuyển đèn vàng ấm, giảm màn hình.
- **Giấc trưa Việt** ☞: 15–30 phút, trước khoảng 15h; đặt báo thức.
- Lời khuyên theo mùa (C3) chỉ ở mức **điều chỉnh nhẹ** (mùa đông miền Bắc dậy muộn hơn chút khi trời còn tối), không thay đổi nguyên tắc giờ dậy đều.
- Người **làm ca đêm**: lộ trình riêng (tối buông ngủ ban ngày, kính râm khi tan ca về, giấc ngủ chính cố định), cần chuyên gia soạn.

B. Điều kiện để ngủ

Cơ chế 3. Tâm yên thì ngủ

Đông lý.

- **Tạng Tâm tàng thần.** Đem đến thần phải về tàng thì mới ngủ; thần không yên (tâm thần bất an) thì mất ngủ.
- Dưỡng sinh cổ truyền: **"Tiên thụ tâm, hậu thụ nhĩ"**: ngủ lòng trước, ngủ mắt sau (thường dẫn từ sách dưỡng sinh đời Tống, *Thụ quyết*; cần xác định xuất xứ).
- **"Tư thương Tỳ"**: lo nghĩ hại Tỳ; Tâm Tỳ lưỡng hư là thể mất ngủ thường gặp (khó ngủ, hay mơ, hồi hộp, ăn kém) [C3].

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Trạng thái tăng kích thích (lo lắng, suy nghĩ dồn dập, cơ thể căng) trước khi ngủ là cơ chế chính duy trì mất ngủ	C1

Hiện tượng	Cấp
Liệu pháp nhận thức hành vi cho mất ngủ (CBT-I) là điều trị hàng đầu cho mất ngủ mạn tính, được khuyến nghị trước thuốc ngủ (hướng dẫn của Hội Thầy thuốc Hoa Kỳ ACP 2016, Hội Nghiên cứu Giấc ngủ châu Âu 2017)	C1
Thành phần CBT-I: kiểm soát kích thích (chỉ lên giường khi buồn ngủ, không nằm thao thức quá lâu), giờ dậy cố định , giáo dục vệ sinh giấc ngủ, xử lý suy nghĩ về giấc ngủ, thư giãn; hạn chế giấc ngủ hiệu quả nhưng cần hướng dẫn chuyên môn	C1
Thư giãn, thở chậm, thiền trước ngủ cải thiện chất lượng giấc ngủ ở mức vừa	C2
Lo lắng về chính giấc ngủ ("phải ngủ đủ 8 tiếng") làm mất ngủ nặng thêm; theo dõi giấc ngủ bằng thiết bị quá mức có thể gây lo âu ("orthosomnia")	C2

Tăng được nuôi: Tâm ●●, Thần ●●●.

Trong app:

- **"Gác lại ngày hôm nay"** 🕒 5 phút, 1-2 giờ trước ngủ: ghi việc ngày mai cần làm và mối lo, để chúng "nằm trên giấy" chứ không "nằm trên gối" (nỗi "giờ lo lắng" của trụ Cẩm xúc).
- **Bài thở và quét thân trước ngủ** (trụ Thiền, cơ chế 1, 2).
- **Quy tắc 20 phút** 🕒 (kiểm soát kích thích): nằm khoảng 20 phút mà không ngủ được thì ra khỏi giường, làm việc nhẹ nhàng dưới ánh đèn mờ, buồn ngủ mới quay lại. Không nhìn đồng hồ liên tục.
- **Giường chỉ để ngủ** 🕒: không làm việc, không lướt điện thoại trên giường.
- **Không tự triển khai "hạn chế giấc ngủ"** trong phiên bản đầu (cần chuyên gia; chống chỉ định ở một số người như động kinh, rối loạn lưỡng cực, người lái xe nghề).

Cơ chế 4. Vị hoà thì ngủ

Đông lý. *Tổ Vấn, "Nghịch điều luận": "Vị bất hoà tắc ngọa bất an":* dạ dày không yên thì nằm không yên. Rượu tính nhiệt, sinh thấp nhiệt, làm thần không yên [C3].

Tây chứng. Đã trình bày ở *Cơ chế trụ Ăn uống* (cơ chế 5, 6, 7). Tóm tắt:

Yếu tố	Tác động lên giấc ngủ	Cấp
Ăn no sát giờ ngủ	Tăng trào ngược, khó ngủ	C1
Caffeine muộn	Uống 6 giờ trước khi ngủ vẫn giảm giấc ngủ; bán thải trung bình khoảng 5 giờ	C1
Rượu	Dễ vào giấc nhưng vỡ giấc nửa đêm sau, giảm giấc REM	C1
Uống nhiều nước buổi tối	Thức dậy đi tiểu đêm	C1-C2
Nicotine	Chất kích thích, làm khó ngủ	C1

Tăng được nuôi: Thân ●, Thần ●●.

Trong app:

- Khi điểm ngủ thấp, app **hỏi ba hướng trước khi khuyên** (lý luận mục IV.3): bữa tối, cà phê, rượu (Vị bất hoà) → màn hình, ánh sáng (cửu thị) → lo nghĩ (tâm động).
- Gợi ý cụ thể lấy từ trụ Ẩn uống: ăn xong trước giờ ngủ 2-3 giờ; ly cà phê cuối trước khoảng 14h (tuỳ giờ ngủ); không dùng rượu để dễ ngủ.

Cơ chế 5. Chỗ ngủ yên

Đông lý.

- **"Cửu thị thương huyết"**: nhìn lâu hại huyết; mà đêm là lúc huyết về Can. Nhìn màn hình khuya là hao huyết hai lần ☹️.
- Dưỡng sinh cổ truyền: chỗ ngủ tránh gió lùa (phong là đầu của lục dâm), không nằm chỗ ẩm thấp, đầu mát chân ấm [C3].

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Phòng ngủ tối, yên tĩnh, mát hỗ trợ giấc ngủ; nhiệt độ phòng quá nóng làm giấc ngủ chập chờn	C1-C2
Tiếng ồn ban đêm (giao thông, hàng xóm) làm vỡ giấc ngủ, liên quan tăng nguy cơ tim mạch (hướng dẫn tiếng ồn của WHO 2018)	C1-C2
Dùng thiết bị điện tử trên giường, nhất là nội dung kích thích, làm muộn giờ ngủ và giảm thời gian ngủ	C2
Ánh sáng trong phòng khi ngủ (đèn, tivi để mở) liên quan chuyển hoá kém hơn trong một số nghiên cứu	C2
Đầu mát chân ấm; hướng giường	C2 (làm ấm bàn chân giúp vào giấc nhanh hơn) / C3 (hướng giường, phong thủy)

Văn hoá và hoàn cảnh Việt ☹️:

- Khí hậu nóng ẩm: điều hoà, quạt, màn chống muỗi là điều kiện ngủ thực tế. Nên khuyên nhiệt độ dễ chịu, **tránh để quạt hay điều hoà thổi thẳng vào người** (gặp "tránh gió lùa" C3 và tránh khô họng, lạnh cục bộ).
- Nhà phố gần đường, karaoke, nhà ở nhiều thế hệ, ngủ chung với con: lời khuyên phải **khả thi** (nút tai, rèm dày, quạt tạo tiếng đều), không đòi hỏi "phòng ngủ riêng hoàn hảo".

Tăng được nuôi: Thân ●, Thần ●●.

Trong app:

- **"Kiểm tra chỗ ngủ"** ☹️ một lần: tối · yên · mát · không màn hình · thoải mái. Gợi ý cải thiện từng mục với chi phí thấp.
- Chế độ **"Đi ngủ"**: nhắc bật chế độ không làm phiền, để điện thoại xa giường (nối trụ Môi trường, cơ chế ánh sáng và màn hình).

C. Nghỉ

Cơ chế 6. Bất vọng tác lao: nghỉ giữa giờ, ngày nghỉ, hồi phục

Đông lý.

- *Thượng cổ thiên chân luận*: "**Bất vọng tác lao**": không lao lực cần.
- "**Lao tắc khí hao**" (*Cử thống luận*): lao lực thì khí hao.
- **Điều hoà âm dương** (pháp tắc 1): động và tĩnh, làm và nghỉ đan xen. "Ngủ nghỉ" không chỉ là ngủ đêm, mà là mọi khoảng **tĩnh** cân bằng cho **động**.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Làm việc từ 55 giờ/tuần trở lên liên quan tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim thiếu máu cục bộ (ước tính của WHO và ILO, 2021)	C1
Nghỉ ngắn trong giờ làm việc giảm mệt mỏi, tăng sức tập trung	C2
Tách rời tâm lý khỏi công việc ngoài giờ (không nghĩ, không trả lời việc) liên quan hồi phục tốt hơn và ít kiệt sức hơn	C2
Kỳ nghỉ cải thiện sức khoẻ tinh thần, nhưng tác dụng phai nhanh sau khi quay lại làm việc	C2
Kiệt sức nghề nghiệp (burnout) được WHO mô tả là hiện tượng nghề nghiệp do căng thẳng công việc kéo dài không được quản lý tốt	C1 (về định nghĩa)

Tầng được nuôi: Khí ●●, Tâm ●●, Thân ●.

Trong app:

- "**Nghỉ năm phút**" 🕒 sau mỗi khoảng 60-90 phút làm việc tập trung: rời màn hình, nhìn xa, đứng dậy, thở (gộp với nhắc của trụ Luyện tập và Thiền thành **một** lời nhắc, tránh làm phiền).
- "**Ranh giới tối**" 🕒: một giờ cố định không xem việc, không email công việc (người dùng tự chọn).
- "**Một ngày tĩnh**" 🕒 mỗi tuần: ngày có ít nhất một khoảng dài không công việc, không mục tiêu (gặp "ngày nghỉ" của trụ Luyện tập).
- Theo dõi **chỉ báo hao tổn** của tầng Thân (lý luận mục II): số đêm thức khuya, số ngày làm việc quá sức trong tuần. Nhiều tuần liên tiếp cao thì nhắc "lao tắc khí hao".

Tổng hợp: trụ Ngủ nghỉ nuôi bốn tầng

Cơ chế	Thân	Khí	Tâm	Thần	Lời khuyên chủ lực (C1)
0. Âm dương giao (nền)	●●●	●	●	●●●	(khung giải thích)

Cơ chế	Thân	Khí	Tâm	Thần	Lời khuyên chủ lực (C1)
1. Túc miên	●●●	●	●	●●●	Ngủ ít nhất 7 giờ
2. Thuận thời	●●	●		●●	Giờ dậy đều; nắng sáng; tối giảm sáng; ngủ trưa ngắn
3. Tâm yên thì ngủ			●●	●●●	CBT-I: kiểm soát kích thích, giờ dậy cố định
4. Vị hoà thì ngủ	●			●●	Bữa tối sớm, cà phê sớm, không rượu
5. Chỗ ngủ yên	●			●●	Tối, yên, mát; màn hình xa giường
6. Bất vọng tác lao	●	●●	●●		Nghỉ giữa giờ; không làm việc quá sức

Khớp với bảng của lý luận v0.3 (Ngủ nghỉ: Thân ●●●, Khí ●, Tâm ●, Thần ●●●). Đề xuất xem xét nâng **Khí lên ●●** nhờ cơ chế 6 (nghỉ ngơi hồi phục khí).

Ngủ nghỉ tác động sang các trụ khác

Đường nối	Cơ chế	Cấp
Ngủ nghỉ → Luyện tập	Thủy sinh Mộc: ngủ đủ thì có sức tập, hồi phục tốt	C1
Luyện tập → Ngủ nghỉ	Vận động đều đặn cải thiện giấc ngủ; tránh gắng sức nặng sát giờ ngủ	C1-C2
Ngủ nghỉ → Ăn uống	Thiếu ngủ tăng đói, thèm đồ ngọt béo	C1-C2
Ăn uống → Ngủ nghỉ	Vị bất hoà tác ngoại bất an; cà phê, rượu, bữa khuya	C1
Thiền → Ngủ nghỉ	Kim sinh Thủy: thở chậm, tĩnh tâm thì dễ ngủ	C2
Ngủ nghỉ ↔ Cảm xúc	Tâm yên thì ngủ; thiếu ngủ làm cảm xúc dễ bùng nổ; mất ngủ là yếu tố nguy cơ trầm cảm	C1
Môi trường → Ngủ nghỉ	Ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, công việc ca đêm	C1-C2

Đo lường trụ Ngủ nghỉ 🛌

Theo nguyên tắc đo của lý luận (mục II): nhanh, ít gánh nặng, không gộp điểm, xem xu hướng.

Check-in buổi sáng (dưới 30 giây)

#	Câu hỏi	Trả lời	Cơ chế
1	Tối qua bạn đi ngủ lúc mấy giờ, sáng dậy lúc mấy giờ?	Giờ (hoặc lấy từ thiết bị)	1, 2
2	Bạn mất bao lâu để ngủ được?	<15 phút · 15-30 · 30-60 · >60	3
3	Đêm qua bạn thức giấc nhiều không?	Không · 1-2 lần · Nhiều lần	3, 4, 5

#	Câu hỏi	Trả lời	Cơ chế
4	Sáng nay bạn thấy đã được nghỉ đến đâu?	0-10	Nền

Giờ ăn tối, ly cà phê cuối, rượu bia lấy từ check-in trụ Ăn uống (không hỏi lại).

Tự động (nếu người dùng cho phép)

- Thời lượng ngủ từ đồng hồ, điện thoại: **dùng làm tham khảo**. Thiết bị đeo đo **thời lượng** khá tốt nhưng đo **các giai đoạn ngủ** kém chính xác; app **không hiển thị "điểm giấc ngủ sâu"** như kết luận.

Hàng tuần

- Độ đều giờ dậy** (chênh lệch giữa các ngày).
- Chỉ báo hao tổn**: số đêm ngủ sau 0h, số ngày làm việc quá sức.

Định kỳ (cần chuyên gia chọn công cụ đã thẩm định tiếng Việt)

- Chỉ số mức độ mất ngủ (ISI)** mỗi 4 tuần nếu người dùng ngủ kém.
- Thang buồn ngủ Epworth (ESS)** khi có than phiền buồn ngủ ban ngày.
- STOP-Bang** (sàng lọc ngưng thở khi ngủ) khi có ngáy to, mệt dù ngủ đủ.

Không đo

- Không xếp hạng giấc ngủ, không so sánh với người khác.
- Không gửi thông báo báo động về một đêm ngủ kém. Chỉ nói về **xu hướng** (lý luận mục X: bảo vệ người hay lo âu).

An toàn riêng cho trụ Ngủ nghỉ

Bổ sung vào mục X của lý luận. **Cần bác sĩ duyệt.**

Cờ đỏ khẩn cấp

Dấu hiệu	Hành động
Buồn ngủ đến mức ngủ gật khi lái xe	Khuyến không lái xe khi buồn ngủ; dừng xe nghỉ ngay; đi khám
Ý nghĩ tự hại (thường đi kèm mất ngủ nặng, trầm cảm)	Theo mục X của lý luận: số 115 và đường dây hỗ trợ đã xác minh

Cờ đỏ cần đi khám

Dấu hiệu	Hành động
Ngáy to, người ngủ cùng thấy ngưng thở, thức dậy thở hổn hển, buồn ngủ ban ngày, tăng huyết áp khó kiểm soát	Nghi ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn : khuyên đi khám (bệnh phổ biến, điều trị hiệu quả, nếu bỏ qua tăng nguy cơ tim mạch, tai nạn)
Mất ngủ ≥ 3 đêm/tuần kéo dài ≥ 3 tháng, ảnh hưởng ban ngày	Mất ngủ mạn tính: khuyên đi khám; giới thiệu CBT-I
Ngủ nhiều, mệt mỏi kéo dài không rõ lý do	Khuyên đi khám (thiếu máu, tuyến giáp, trầm cảm...)
Khó chịu, bứt rứt ở chân buổi tối, phải cử động mới đỡ	Nghi hội chứng chân không yên: khuyên đi khám
Ngủ gật đột ngột ban ngày, yếu cơ khi cười hoặc xúc động	Khuyên đi khám chuyên khoa
Hành vi bất thường khi ngủ: la hét, đánh đấm theo giấc mơ, mộng du gây nguy hiểm	Khuyên đi khám

Thuốc ngủ và thực phẩm chức năng

- App **không gợi ý thuốc ngủ**, không gợi ý **melatonin** hay sản phẩm hỗ trợ ngủ. Melatonin ở một số nơi được bán như thực phẩm chức năng nhưng không phải lựa chọn hàng đầu cho mất ngủ mạn tính và có thể tương tác thuốc; cần hỏi bác sĩ.
- Người đang dùng thuốc ngủ: nhắc **không tự ý ngưng đột ngột** (có thể gây mất ngủ dội ngược, một số thuốc gây triệu chứng cai), trao đổi với bác sĩ.
- Không gợi ý **rượu thuốc, rượu ngâm để dễ ngủ**.

Khoá và điều chỉnh

Tình trạng	Điều chỉnh
Làm ca đêm, ca xoay	Lộ trình riêng; không áp "giờ dậy đều" chuẩn
Thai kỳ	Gợi ý tư thế nằm nghiêng (theo bác sĩ sản); ngáy mới xuất hiện, phù, đau đầu thì khám
Có con nhỏ, chăm người bệnh	Không đặt mục tiêu "7 giờ liên tục"; gợi ý ngủ bù khi có thể, chia sẻ việc chăm sóc
Rối loạn lưỡng cực, động kinh	Không gợi ý thức khuya, hạn chế giấc ngủ; giấc ngủ đều đặn đặc biệt quan trọng

Lộ trình tiệm tiến gợi ý 🦉

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
1	Thuận thời	Chọn một giờ dậy cố định, giữ cả tuần
2	Thuận thời	Đón nắng sáng 10-20 phút

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
3	Vị hoà	Ly cà phê cuối trước 14h; ăn tối xong trước giờ ngủ 3 tiếng
4	Chỗ ngủ	"Hoàng hôn trong nhà"; điện thoại xa giường
5	Tâm yên	"Gác lại ngày hôm nay" và bài thở trước ngủ
6	Tâm yên	Quy tắc 20 phút nếu nằm không ngủ được
7-12	Túc miên, nghỉ	Lùi giờ ngủ sớm dần đến đủ 7 giờ; ranh giới tối; ngày tĩnh mỗi tuần

Hai lối vào theo bốn tầng:

- Người **mệt mỏi, suy nhược** (Thân yếu): Ngủ nghỉ là cửa vào đầu tiên; bắt đầu từ cơ chế 1, 2.
- Người **căng thẳng, khó ngủ vì lo nghĩ** (Tâm, Thần yếu): bắt đầu từ cơ chế 3 kết hợp trụ Thiền và trụ Cảm xúc.

Việc cần hội đồng thẩm định

Lương y:

1. Đối chiếu nguyên văn: *Linh Khu "Khẩu vấn", "Doanh vệ sinh hội", "Đại hoặc luận", Ngũ tạng sinh thành, Nghịch điều luận, Cử thống luận, Tứ khí điều thần đại luận*; xuất xứ "Tý Ngọ giác", "tiên thụ tâm, hậu thụ nhãn".
2. Các thể mất ngủ cổ truyền dùng làm khung giải thích (không chẩn đoán).
3. Điều chỉnh giờ ngủ theo mùa cho miền Bắc, miền Nam.

Bác sĩ chuyên về giấc ngủ, chuyên gia tâm lý:

1. Nội dung các bài theo CBT-I có thể đưa vào app an toàn; ranh giới với điều trị.
2. Bộ cờ đỏ (ngưng thở khi ngủ, chân không yên, ngủ rũ, hành vi khi ngủ).
3. Công cụ ISI, ESS, STOP-Bang bản tiếng Việt đã thẩm định.
4. Lộ trình cho người làm ca đêm, người có con nhỏ.
5. Chính sách về thuốc ngủ, melatonin, thực phẩm chức năng.
6. Xếp cấp C1/C2/C3 cho từng khẳng định.